

TEMA 2.2 • DIABETES Y DISLIPIDEMIAS

Diagnostico de Diabetes

PERFIL EUNACOM 1.04.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diagnóstico de Diabetes Mellitus

Criterios Diagnósticos (persona NO embarazada)

TABLA 2.2.1: CRITERIO VS VALOR	
CRITERIO	VALOR
2 glicemias de ayuno	≥ 126 mg/dL
TTOG 2h post 75g glucosa	≥ 200 mg/dL
Cualquier glicemia + síntomas	≥ 200 mg/dL
HbA1c	≥ 6,5%

EUNACOM CRITERIOS

Sin síntomas → siempre repetir el examen antes de confirmar. Con síntomas (polidipsia, poliuria, baja de peso, visión borrosa) → 1 sola glicemia ≥ 200 basta.

Estados Intermedios (Prediabetes)

TABLA 2.2.2: DIAGNÓSTICO VS CRITERIO	
DIAGNÓSTICO	CRITERIO
Glicemia ayuno alterada	100–125 mg/dL
Intolerancia a la glucosa oral	TTOG 2h: 140–199 mg/dL
Resistencia a la insulina	HOMA > 2,6

HbA1c: cuándo usar como diagnóstico

- Cuando hay un **descompensante activo** (infección, pancreatitis) → la glicemia estará alta por estrés y no refleja DM real
- Cuando se sospecha que el paciente hizo un **ayuno prolongado** (falso negativo de glicemia ayuno)

Screening en adultos asintomáticos

"" Glicemia en ayuno | | < 100 → Normal → No hacer nada | | 100–125 → Glicemia de ayuno alterada → Pedir TTOG | | < 140 → Solo glicemia ayuno alterada | | 140–199 → Intolerancia + glicemia

ayuno alterada | | ≥ 200 → Diabetes (no requiere repetición si está en TTOG) | | ≥ 126 → Diagnóstico provisorio de DM → Repetir | Sale ≥ 126 de nuevo → Diabetes confirmada | Sale < 126 → No confirmado → Pedir TTOG ""

Paciente hospitalizado con hiperglicemia

- No usar glicemia de ayuno ni TTOG → usar **HbA1c** para saber si tenía DM antes de la hospitalización

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 50 años hospitalizado por neumonía grave presenta glicemia de 260 mg/dL. No tiene diagnóstico previo de diabetes. ¿Cuál es la conducta más adecuada para evaluar si tiene diabetes?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diagnóstico de Diabetes. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Criterios diagnósticos: dos glicemias de ayuno mayor o igual a 126, TTGO mayor a 200 a las 2 horas, o glicemia mayor a 200 mas síntomas.
- Los criterios confirman diabetes pero NO diferencian el tipo.
- HbA1c mayor a 6.5% es diagnóstica. Es de elección cuando hay descompensante (infección) o sospecha de no cumplir ayuno.
- Prediabetes: glicemia de ayuno alterada (100-125) e intolerancia a la glucosa oral (TTGO 140-199).
- Resistencia a la insulina: HOMA mayor a 2.6 (glicemia x insulina / 405).
- Screening con glicemia de ayuno: menor a 100 normal, 100-125 pedir TTGO, mayor o igual a 126 repetir.
- Con descompensante (infección, pancreatitis), la glicemia no sirve para diagnosticar diabetes. Usar HbA1c.
- Síntomas de diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia, baja de peso, visión borrosa.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIAGNOSTICO DE DIABETES)

PREGUNTA 1

Paciente de 50 años hospitalizado por neumonía grave presenta glicemia de 260 mg/dL. No tiene diagnóstico previo de diabetes. ¿Cuál es la conducta más adecuada para evaluar si tiene diabetes?

- A) Repetir la glicemia de ayuno mañana
- B) Solicitar hemoglobina glicosilada
- C) Realizar TTGO de 75 gramos
- D) Diagnosticar diabetes con esta glicemia
- E) No es necesario estudiar, la hiperglicemia es por la infección

PREGUNTA 2

Paciente de 42 años asintomático, se realiza glicemia de ayuno de control que resulta en 112 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Diagnosticar prediabetes y no hacer nada más
- B) Repetir la glicemia de ayuno
- C) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- D) Iniciar metformina de inmediato
- E) Solicitar hemoglobina glicosilada

PREGUNTA 3

Paciente de 35 años consulta por polidipsia, poliuria y baja de peso de 5 kg en un mes. La glicemia al azar es de 245 mg/dL. ¿Cuál es la conducta?

- A) Repetir la glicemia de ayuno para confirmar
- B) Solicitar TTGO de 75 gramos
- C) Confirmar diabetes de inmediato e iniciar tratamiento
- D) Solicitar hemoglobina glicosilada para confirmar
- E) Observar y controlar en 3 meses

RESUMEN: DIAGNOSTICO DE DIABETES

Los criterios diagnósticos de diabetes mellitus confirman la existencia de diabetes pero no diferencian el tipo. Los tres criterios son: dos glicemias de ayuno mayor o igual a 126 mg/dL, una glicemia mayor a 200 en un TTGO de 75 gramos a las 2 horas, o una glicemia al azar mayor a 200 más síntomas de diabetes (polidipsia, poliuria, polifagia, baja de peso, visión borrosa). La hemoglobina glicosilada mayor a 6.5% es un criterio válido, especialmente útil cuando hay un descompensante claro (infección, pancreatitis) que puede generar hiperglicemia per se, o cuando se sospecha que el paciente no cumple el ayuno adecuado. La HbA1c refleja los últimos 2-3 meses de control metabólico. Existen diagnósticos relacionados que no son diabetes propiamente tal: resistencia a la insulina (HOMA mayor a 2.6), glicemia de ayuno alterada (100-125 mg/dL), e intolerancia a la glucosa oral (TTGO a las 2 horas entre 140-199). Los dos últimos se denominan prediabetes. El screening se hace con glicemia de ayuno: menor a 100 es normal, entre 100-125 se pide TTGO, y mayor o igual a 126 se repite para confirmar diabetes.